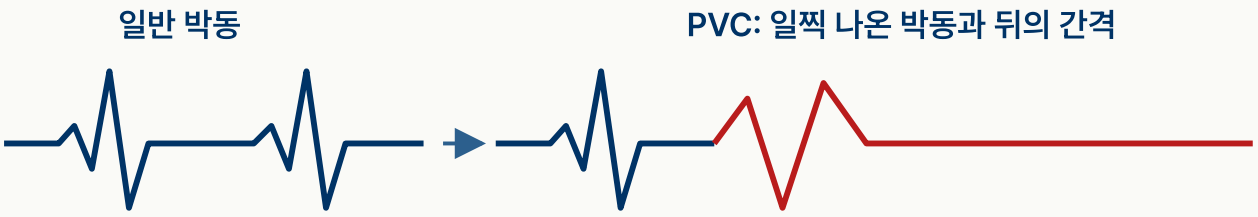
맥이 건너뛰는 느낌, PVC일 수 있어요

심실조기수축(PVC)은 심실에서 박동이 일찍 나오는 것입니다. 증상의 세기와 실제 발생 비율은 같지 않습니다.

박동의 느낌과 검사로 보는 것



느낌만으로 하루 발생 비율은 알기 어렵습니다

일찍 나온 박동 뒤의 간격 때문에 맥이 건너뛰거나 가슴이 철렁한다고 느낄 수 있습니다.

증상보다 먼저 보는 것은 심장 상태입니다

느낌은 다양합니다

아무 증상이 없기도 하고, 가슴이 답답하거나 맥이 느리게 느껴지기도 합니다. 피로·숨참·기침·소화불량처럼 나타날 수도 있습니다.

기저 심장질환이 중요합니다

심근경색이나 다른 심장질환이 있는지 함께 봅니다. 기저 심장질환이 없고 PVC 발생 비율이 낮으면 대체로 경과가 좋습니다.

추가 검사는 서로 다른 것을 봅니다

홀터·패치 심전도	일상생활 중 박동을 기록해 PVC 비율(burden)을 봅니다. 짧은 심전도 한 번만으로 하루 비율을 판단하기 어렵습니다.
심장초음파	심장 크기와 수축 기능, 박출률(EF)을 봅니다. PVC가 잦으면 처음 상태를 기록해 두는 데 도움이 됩니다.

! 두근거림과 함께 이런 증상이 있다면

실신하거나 쓰러질 듯한 느낌, 심한 흉통이나 호흡곤란이 함께 있으면 전문 진료가 필요한 상황입니다. 증상과 검사 기록을 함께 전달합니다.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

PVC 비율과 심장 기능을 함께 추적해요

비율 하나만으로 치료를 정하지 않습니다. 증상, 심장 크기, 박출률의 변화를 함께 봅니다.

PVC 비율을 읽는 법

5~10%	심장 크기와 EF가 정상이고 증상이 크지 않으면 이 비율만으로 항부정맥제를 꼭 시작하지는 않습니다. 일부에서는 심장 변화가 생길 수 있어 경과를 함께 봅니다.
10% 이상	심장 기능이 떨어지거나 커질 가능성을 살펴 초음파 추적을 고려합니다. 연자 Q&A에서는 1~2년에 한 번 초음파 추적을 설명했습니다.
20% 이상	심근병증 가능성이 더 커져 초음파를 더 자주, 적극적으로 추적합니다. 모든 분에게 심부전이 생긴다는 뜻은 아닙니다.

10%가 안전과 위험을 가르는 절대선은 아닙니다

과거에는 20~25%를 강조했지만 최근에는 10% 정도부터 위험 증가를 살핍니다. 일부에서 6~8%에도 회복 가능한 PVC 관련 심근병증이 보고되어, 발생 비율은 연속적인 위험으로 이해합니다.

다음 진료에서 함께 볼 내용

1. 홀터 비율은 날마다 달라질 수 있습니다. 처음 낮았어도 한두 번 반복해 낮게 유지되는지 살펴볼 수 있습니다.
2. 검사 뒤에도 증상이 심하거나 PVC가 늘고, 심장이 커지거나 EF가 줄면 전문 평가를 받습니다.
3. 증상이 심하거나 심장 기능 변화가 있으면 약물치료를 고려합니다. 약에 반응하지 않고 심부전이 동반되면 도자절제술을 고려하기도 합니다.

치료로 회복될 수 있는 변화를 찾는 과정입니다

PVC 때문에 심장 기능이 떨어진 경우에는 PVC를 줄이는 약물이나 도자절제술 뒤 기능이 회복되기도 합니다. 그래서 증상과 반복 검사 결과를 함께 보는 것이 중요합니다.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/cardio/asl28-pvc-tests-and-follow-up/